



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PROGRAM
KOMITE PENINGKATAN MUTU DAN
KESELAMATAN PASIEN RS PRIMA HUSADA
MALANG
TAHUN 2026**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

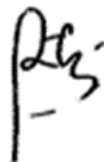
Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

LEMBAR PENGESAHAN

Program PMKP
Rumah Sakit Prima Husada Malang
Tahun 2026

Disusun oleh:

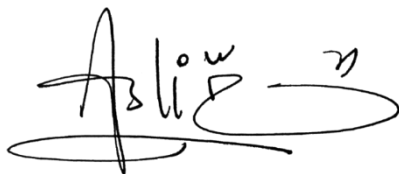
Ketua Komite Mutu Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Ari Putriani, Sp.PK)

Disetujui oleh:

Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP.)

Ditetapkan oleh:

PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Resti Lestantini, M.Kes)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Program Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Prima Husada Malang dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Program Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Prima Husada Malang disusun sebagai upaya untuk terselenggaranya kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta standart akreditasi.

Program ini akan dievaluasi kembali dan akan dilakukan apabila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai lagi dengan kondisi Rumah Sakit Prima Husada Malang. Kami mengucapkan terima kasih kepada piha pihak yang dengan segala upaya telah berhasil menyusun program ini yang merupakan kerjasama dengan berbagai pihak.

Malang, 17 Desember 2025

Penyusun

Komite Mutu Rumah Sakit

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pasien dan menjamin keselamatan pasien maka rumah sakit Prima Husada Malang perlu mempunyai program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP) yang menjangkau ke seluruh unit kerja di rumah sakit Prima Husada Malang.

Untuk melaksanakan program tersebut tidaklah mudah karena memerlukan koordinasi dan komunikasi yang baik antara kepala bidang/divisi medis, keperawatan, penunjang medis, administrasi, dan lainnya termasuk kepala unit/departemen/ instalasi pelayanan.

Rumah sakit telah menetapkan komite PMKP untuk mengelola program peningkatan mutu dan keselamatan pasien agar mekanisme koordinasi pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien dapat berjalan lebih baik.

Program ini menjelaskan pendekatan yang komprehensif untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang berdampak pada semua aspek pelayanan. Pendekatan ini mencakup:

1. Setiap unit terlibat dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
2. Rumah sakit menetapkan tujuan mengukur seberapa baik proses kerja dilaksanakan
3. Validasi datanya menggunakan data secara efektif dan fokus pada tolok ukur program; dan
4. Bagaimana menerapkan dan mempertahankan perubahan yang telah menghasilkan perbaikan.

Agar peningkatan mutu dan keselamatan pasien dapat berjalan baik, Direktur Rumah Sakit, para kepala bidang/divisi, serta kepala unit dan departemen di rumah sakit:

1. Wajib mendorong pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP);
2. Berupaya mendorong pelaksanaan budaya mutu dan keselamatan (patientsafety culture);
3. Secara proaktif melakukan identifikasi dan menurunkan variasi;
4. Menggunakan data agar fokus kepada prioritas isu;
5. Berupaya menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum

- 1.2.1** Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 1.2.2** Undang – Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- 1.2.3** Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit
- 1.2.4** Instrumen Survei Akreditasi RS 2024
- 1.2.5** Keputusan Direktorat Jendral No HK.02.02.D.43961.2024 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit
- 1.2.6** Buku Standar Akreditasi RS Kemenkes RI 2022
- 1.2.7** Peraturan Menteri Kesehatan No 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit
- 1.2.8** Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Terselenggaranya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit Prima Husada Malang secara berkelanjutan dan berkesinambungan sesuai dengan visi dan misi Rumah Sakit Prima Husada Malang.

1.3.2 Tujuan

1. Meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Prima Husada Malang sesuai dengan standar indikator yang ada
2. Meningkatkan keselamatan pasien melalui pelaporan insiden dan penerapan sasaran keselamatan pasien
3. Tersedianya SDM yang profesional dan berkualitas
4. Tersedianya sarana, prasarana dan peralatan medis yang memadai
5. Terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk karyawan, pasien dan pengunjung rumah sakit

BAB II
GAMBARAN UMUM

2.1 Visi

Rumah Sakit Prima Husada memiliki visi :
“ Menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat.”

2.2 Misi

- Rumah Sakit Prima Husada memiliki misi :
- 1. Memberikan pelayanan Kesehatan dengan aman, tepat, cepat, dan akurat.
 - 2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien.
 - 3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan.

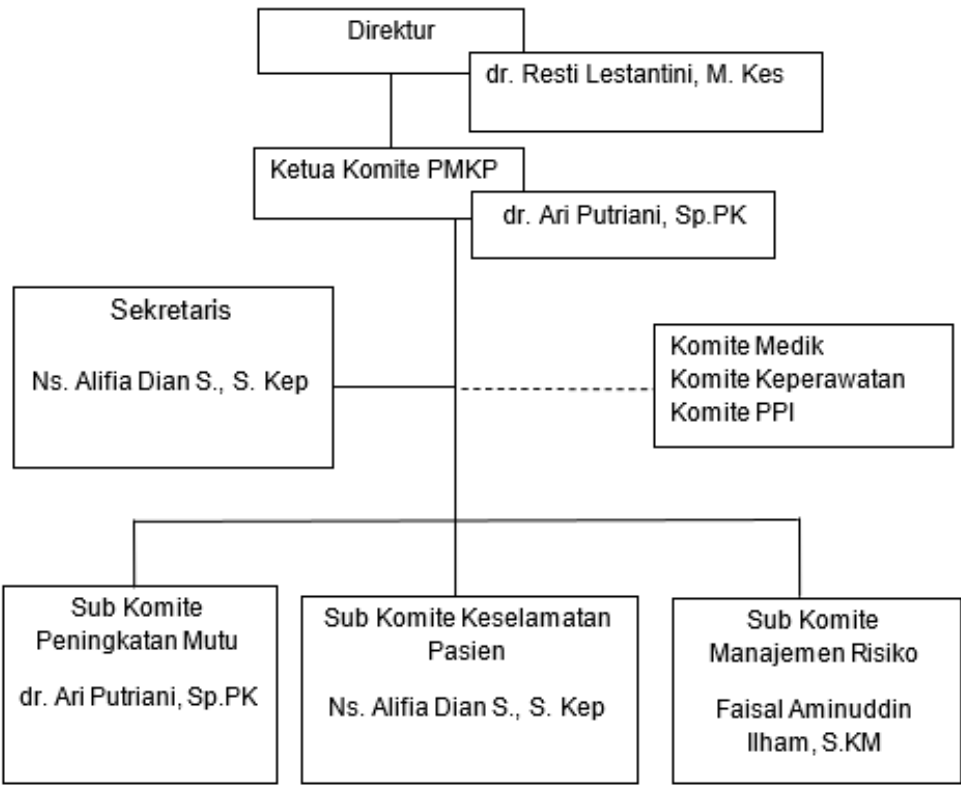
2.3 Motto

“Sahabat Menuju Sehat”

2.4 Landasan 7 Nilai Budi Utama

- Rumah Sakit Prima Husada memiliki Landasan 7 Nilai Budi Utama :
- 1. Jujur dan dipercaya
 - 2. Tanggung Jawab
 - 3. Visioner
 - 4. Disiplin
 - 5. Kerjasama
 - 6. Adil
 - 7. Peduli

2.5 SOTK Komite PMKP



BAB III
KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN

3.1 KEGIATAN POKOK

No	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1.	Orientasi	1. Persiapan orientasi 2. Pelaksanaan orientasi 3. Monev & pelaporan hasil orientasi
2.	Pendidikan dan Pelatihan (Seminar dan Workshop) terkait Mutu	1. Pelatihan Eksternal: a. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dan Manajemen Resiko b. Penyusunan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan Root Cause Analysis (RCA) c. Implementasi Kendali Mutu Biaya pada bab PMKP 2. Pelatihan Internal: a. <i>Refreshment & Training</i> PMKP b. Pelatihan Pengambilan Data Mutu (PIC): • Materi: 1) Refreshment Indikator Mutu yang berlaku di Unit 2) Alur Pengumpulan Data Mutu baik di SIMRS 3) Cara analisa permasalahan sesuai dengan kondisi di unit sampai dengan tindak lanjut perbaikan 4) Praktik mengumpulkan data Mutu baik di SIMRS 5) Praktik mengunduh laporan mutu di SIMRS c. Pelatihan terkait pengisian CP di Unit: (Kolaborasi dengan Komite Medik) • Sasaran: PPA (Program Pemberi Asuhan) yakni DPJP, Perawat, Bidan, Gizi dan Farmasi • Materi: 1) Refreshment Praktik Klinis yang dilakukan Audit 2) Pengisian Form CP di <i>Google Spreadsheet</i>
3.	Perencanaan Mutu RS	1. Review & Revisi Regulasi Mutu a. SK Komite Mutu b. Perdir - Pedoman Mutu RS c. SK PJ.& Validator Mutu Unit d. SK PIC Data Mutu Unit e. SK Sistem Pelaporan dan Pembelajaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit (SP2KP RS) f. SPO 2. Membuat Program kerja : a. Program Mutu RS (PMKP, Keselamatan Pasien, Manajemen Risiko)

No	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
		b. Program / Survey Budaya Keselamatan Pasien c. Program Budaya Keselamatan Rumah Sakit 3. Pengumpulan dan analisis data tahun 2025 sebagai bahan untuk pemilihan indikator Mutu tahun 2026
4.	Penetapan Indikator Mutu	1. Pengumpulan usulan mutu unit 2. Rapat koordinasi penentuan mutu Unit 3. Rapat penetapan IMPRS 4. Penetapan dan pengesahan Indikator Mutu RS
5.	Pelaksanaan Pengukuran Mutu RS	1. Validasi data oleh Komite atau Direktur sesuai standard 2. Penerimaan data mutu dari unit 3. Rekapitulasi data di mutu Tingkat RS dan analisa data 4. Membuat rencana perbaikan & pelaksanaan perbaikan 5. Feedback Hasil pengukuran Mutu ke Unit
6.	Monev (Monitoring/pemantauan dan Evaluasi) Mutu	1. Memantau pengumpulan dan analisa data di masing-masing unit (INM, IMP-RS, IMP- Unit) 2. Memantau Validasi data oleh PJ Mutu Unit sesuai standard
7.	Pelaporan Mutu	1. Pelaporan Mutu RS ke Direktur RS 2. Pelaporan Mutu RS ke PT.DPM 3. Benchmark Mutu antar RS Tipe C 4. Pelaporan Mutu RS ke Kemenkes (SIMAR) 5. Pelaporan Mutu RS ke Dinkes Kabupaten Malang
8.	Penerapan Standar Pelayanan Kedokteran di Rumah Sakit (PPK-CP)	1. Evaluasi CP dengan Komite Medik 2. Audit medis dengan Pimpinan Medis dan Komite Medik 3. Rapat koordinasi hasil monitoring dan audit medis PPK - CP
9.	Pelaksanaan Pengukuran Budaya Keselamatan	1. Pengukuran budaya keselamatan 2. Analisa dan tindak lanjut hasil budaya keselamatan 3. Pelaporan hasil budaya Keselamatan ke Direktur RS 4. Pelaporan budaya Keselamatan RS ke PT.DPM 5. Penyusunan program budaya keselamatan untuk tahun berikutnya
10.	Pelaksanaan Pengukuran Manajemen Risiko	1. Penyusunan identifikasi risiko ditingkat unit dan tingkat RS 2. Penyusunan Risk register 3. Penyusunan strategi untuk menurunkan risiko 4. Monitoring dan evaluasi terhadap risiko di unit 5. Pelaporan hasil monitoring kepada direktur dan representative pemilik 6. Penyusunan FMEA 7. Monitoring tindak lanjut FMEA 8. Pelaporan FMEA ke Direktur RS

3.2 Sasaran

No	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
1.	Orientasi						
	1. Persiapan orientasi 2. Pelaksanaan orientasi 3. Monev & pelaporan hasil orientasi	Meningkatkan pengetahuan karyawan baru terkait program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) di RS Prima Husada Malang	Karyawan Baru	Pembelajaran Kontekstual	Terpenuhi	1. 100% karyawan baru mengikuti pelatihan 2. 100% karyawan baru yang mengikuti pelatihan mengalami peningkatan pengetahuan & keterampilan	
2.	Pendidikan dan Pelatihan (Seminar dan Workshop) terkait Mutu						
a.	Pelatihan Eksternal						
	1) Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dan Manajemen Resiko	Meningkatkan pengetahuan, softskill dalam managerial tim PMKP	1. Ketua PMKP 2. Sekretaris PMKP 3. Ketua Sub Komite Peningkatan Mutu 4. Ketua Sub Keselamatan Pasien 5. Ketua Sub Manajemen Risiko	Diklat	1 kali dalam setahun	Adanya : 1. Sertifikat 2. Materi 3. Laporan 4. Surat Tugas	Diklat diselenggarakan oleh KARS
	2) Pelatihan Penyusunan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan Root Cause Analysis (RCA)	Meningkatkan pengetahuan, softskill dalam	1. Ketua PMKP 2. Sekretaris PMKP 3. Ketua Sub Keselamatan Pasien	Diklat	1 kali dalam setahun	Adanya : 1. Sertifikat 2. Materi 3. Laporan	Diklat diselenggarakan oleh KARS

No	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
		manajerial tim PMKP				4. Surat Tugas	
	3) Pelatihan Implementasi Kendali Mutu Biaya pada bab PMKP	Meningkatkan pengetahuan, softskill dalam manajerial tim PMKP	1. Ketua Komite PMKP 2. Sekretaris PMKP 3. Ketua Sub Komite Peningkatan Mutu	Diklat	1 kali dalam setahun	Adanya : 1. Sertifikat 2. Materi 3. Laporan 4. Surat Tugas	Diklat diselenggarakan oleh KARS
b.	Pelatihan Internal						
	1) <i>Refreshment & Training</i> PMKP Materi: a) Indikator Mutu Nasional, Indikator Mutu Prioritas RS, Indikator Mutu Unit b) Macam-macam Insiden Keselamatan Pasien dan Alur Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien c) Budaya Keselamatan Pasien	Memperkuat dan memperbarui pengetahuan serta keterampilan terkait program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) di RS Prima Husada Malang	All Staff	Sosialisasi & Pelatihan	100% karyawan	1. 100% karyawan mengikuti pelatihan 2. 100% karyawan yang mengikuti pelatihan mengalami peningkatan pengetahuan & keterampilan	

No	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	d) Manajemen Resiko						
	2) Pelatihan Pengambilan Data Mutu Materi: a) Refreshment Indikator Mutu yang berlaku di Unit b) Alur Pengumpulan Data Mutu baik di SIMRS c) Cara analisa permasalahan sesuai dengan kondisi di unit sampai dengan tindak lanjut perbaikan d) Praktik mengumpulkan data Mutu baik di SIMRS Praktik mengunduh laporan mutu di SIMRS	Meningkatnya kemampuan PIC Mutu Unit dalam pengumpulan data, analisa data, dan interpretasi data	PIC Mutu Unit	Pelatihan Internal	1 kali dalam setahun	1. Semua PIC dapat mengumpulkan, menganalisa dan menginterpretasi indikator mutu unit nya 2. Semua PIC mutu mendapatkan sertifikat pelatihan pengambilan data mutu	
	3) Pelatihan terkait pengisian CP di Unit Materi:	Meningkatnya kemampuan PPA	Karu Rawat Inap, Dokter, Gizi, Farmasi	Pelatihan Internal	1 kali dalam setahun	1. Semua PPA dapat mengisi Form CP	

No	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	a) Refreshment Praktik Klinis yang dilakukan Audit b) Pengisian Form CP di Google Spreadsheet	(Profesional Pemberi Asuhan) pengumpulan data, analisa data, dan interpretasi data				2. Semua PPA mendapatkan sertifikat pelatihan pengisian CP	
4.	Perencanaan Mutu RS						
	Regulasi terkait Komite Mutu. Regulasi di review dan di buat sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak ada regulasi yang <i>expired</i> . Regulasi yang perlu di review yakni: 1. Penetapan SK Komite Mutu 2. Penetapan SK PJ Mutu 3. Penetapan SK PIC Mutu 4. Penetapan SK Validator Mutu 5. Penetapan Pedoman Komite Mutu RS 6. Penetapan Program Kerja Komite Mutu RS	Memperbarui regulasi mutu sesuai dengan undang-undang / PMK yang berlaku	Komite PMKP	Review Dokumen Regulasi	1 kali dalam setahun	Regulasi dapat terbaru sesuai UU/PMK/Pedoman Terbaru	

No	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	7. Penetapan tentang Sistem Pelaporan dan Pembelajaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit (SP2KP RS) 8. Penetapan tentang Program Budaya Keselamatan Rumah Sakit 9. Penetapan tentang Program Manajemen Risiko Tingkat Rumah Sakit						
.3	Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM). Indikator Nasional Mutu adalah indikator mutu nasional yang wajib dilakukan pengukuran dan digunakan sebagai informasi mutu secara nasional. Adapun Indikator Nasional Mutu (INM) adalah sebagai berikut:	Sebagai tolak ukur kepatuhan dan bahan analisa capaian RS dalam menjalankan INM	Setiap Unit di RS	Observasi lapangan	Setiap bulan	Indikator Nasional Mutu terlaksana dengan data real dan sesuai dengan kondisi lapangan	

No	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	1. Kepatuhan kebersihan tangan ($\geq 85\%$) 2. Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (100%) 3. Kepatuhan identifikasi pasien (100%) 4. Waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi ($>80\%$) 5. Waktu tunggu rawat jalan ($\geq 80\%$) 6. Penundaan operasi elektif ($<5\%$) 7. Kepatuhan waktu visite dokter ($\geq 80\%$) 8. Pelaporan hasil kritis laboratorium (100%) 9. Kepatuhan penggunaan formularium nasional ($\geq 80\%$)						

No	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	10. Kepatuhan terhadap alur klinis (<i>Clinical Pathway</i>) ($\geq 80\%$) 11. Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh (100%) 12. Kecepatan waktu tanggap komplain ($\geq 80\%$) 13. Kepuasan pasien (76.61%) Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut: a. Terlaksananya pengumpulan dan analisa data b. Terlaksananya pelaporan indikator mutu Nasional ke Aplikasi SIMAR c. Terlaksananya rencana perbaikan & pelaksanaan perbaikan d. Terlaksananya monitoring						

No	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	indikator nasional mutu						
4.	Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit (IMP-RS) 1. Direkur beserta Komite Mutu RS. Prima Husada Malang melakukan persiapan berupa pertemuan atau rapat dengan seluruh kepala ruangan, sehingga ada kesamaan pengertian tentang mutu, keselamatan pasien dan manajemen risiko sehingga ditemukan kesepakatan tentang langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan. 2. Pemilihan Indikator Mutu Prioritas RS (IMP-RS) dan sesuai dengan TKRS 5 mencakup:	Memilih Indikator Mutu Prioritas RS 2026 untuk dilakukan target perbaikan pada tahun 2026	Layanan Terkait Diabeters Melitus	FGD (<i>Focus Group Discussion</i>)	1. Penentuan IMP RS dilakukan 1 kali dalam setahun 2. Pengambilan data IMP RS dilakukan setiap hari 3. Pelaporan Capaian Indikator Mutu dilakukan setiap bulan	1. Indikator Mutu Prioritas RS terlaksana dengan data real dan sesuai dengan kondisi lapangan 2. Adanya SK penetapan Indikator Mutu Prioritas RS	

No	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	a. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien (ISKP) b. Indikator Pelayanan Klinis Prioritas c. Indikator sesuai Tujuan Strategis Rumah Sakit (KPI) d. Indikator terkait Perbaikan Sistem e. Indikator terkait Manajemen Risiko 3. Indikator pelayanan klinis prioritas ditetapkan melalui SK penetapan direktur. 4. Terlaksananya pengumpulan data, analisa, interpretasi data dan <i>feedback</i> data 5. Terlaksananya pelaporan capaian indikator mutu prioritas RS						
5.	Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Unit	Memilih Indikator Mutu Prioritas Unit 2025 pada tahun	Setiap unit di RS	FGD	1. Penentuan IMP Unit dilakukan 1 kali dalam setahun	1. Indikator Mutu Prioritas Unit terlaksana dengan data	

No	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP – Unit) adalah indikator prioritas yang khusus dipilih kepala unit terdiri dari minimal 1 indikator. Adapun uraiannya sebagai berikut: 1. Terlaksananya pemilihan Indikator Mutu Unit 2. Terlaksananya penetapan Indikator Mutu Unit a. IGD b. Instalasi Rawat Jalan c. Instalasi Rawat Inap 2A d. Instalasi Rawat Inap 2C e. Instalasi Rawat Inap 3A f. Instalasi Rawat Inap 4A g. Instalasi Rawat Inap 3C Anak h. Instalasi Rawat Inap 5C i. Instalasi Rawat Inap 6A	2024, untuk dilakukan target perbaikan pada tahun 2025			2. Pengambilan data IMP Unit dilakukan setiap hari 3. Pelaporan Capaian Indikator Mutu dilakukan setiap bulan	real dan sesuai dengan kondisi lapangan 2. Adanya SK penetapan Indikator Mutu Prioritas Unit	

No	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	j. Instalasi Rawat Inap 7A k. Instalasi Rawat Inap 8A l. Instalasi Kamar Operasi m. Maternitas n. Ponak o. Neonatologi p. ICU q. HCU r. Radiologi s. Laboratorium t. Rehab Medis u. Farmasi v. Gizi w. Rekam Medis dan Pendaftaran x. K3RS y. SDM z. Kesekretariatan aa. Driver bb. Kamar Jenazah cc. IPSRS dd. Laundry ee. CSSD ff. Cleaning Service gg. Security hh. Gudang Umum ii. PPI jj. PKRS						

No	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	kk. Asuransi Center ll. Humas & Marketing mm. MOD-MPP-PIPP nn. TB oo. Kasir pp. HIV qq. KB rr. Stunting ss. IT-SIMRS 3. Terlaksananya pengumpulan dan analisa data 4. Terlaksananya pelaporan indikator mutu unit 5. Terlaksananya rencana perbaikan & pelaksanaan perbaikan 6. Terlaksananya monitoring mutu unit kerja						
6.	Analisa, Pelaporan dan <i>feedback</i> data indikator mutu terintergrasi 1. Terlaksananya pengumpulan data	Untuk mendata setiap indikator yang berlaku di setiap unit sebagai bahan	Setiap unit di RS	Observasi lapangan & Analisa data	1. Terlaksana 100% 2. Terlaksana 100%	Terlaksananya tindak lanjut untuk setiap unit yang melaporkan capaiannya	

No	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	indikatotor mutu oleh PIC disetiap unit kerja sesuai dengan profil indikator 2. Terlaksananya analisa data pencapaian indikator sesuai dengan ketentuan analisa data 3. Terlaksananya validasi data sesuai dengan ketentuan validasi data 4. Terlaksananya pelaporan data indikator mutu dari tingkat unit sampai dengan ke pemilik 5. Terlaksananya penyampaian <i>feedback</i> hasil capaian indikator mutu ke semua staf di unit kerja 6. Terlaksananya publikasi data indikator mutu. 7. Terlaksananya <i>benchmark</i> data	yang digunakan untuk menganalisis berbaikan / berburukan dan dilakukan tindaklanjut dan feedback perbaiki kepada setiap unit			3. Terlaksana 100% 4. Terlaksana 100% 5. Terlaksana 100% 6. Terlaksana 100% 7. Terlaksana 100%		

No	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
8.	Penerapan Standar Pelayanan Kedokteran di Rumah Sakit. Terkait dengan pengukuran prioritas perbaikan pelayanan klinis yang ditetapkan oleh Direktur, maka direktur bersama-sama dengan pimpinan medis, ketua komite medik menetapkan paling sedikit 5 evaluasi pelayanan prioritas standar pelayanan kedokteran. 1. Terlaksananya evaluasi CP dengan Komite Medik 2. Terlaksananya audit medis dengan Pimpinan Medis dan Komite Medik	1. Untuk menilai efektivitas penerapan standar pelayanan kedokteran di rumah sakit 2. Untuk mengurangi variasi dari proses, hasil dan efisiensi biaya	1. PPA (Profesional Pemberi Asuhan) yakni: a. DPJP b. Perawat/Bidan c. Gizi d. Farmasi 2. Komite PMKP 3. Komite Medik	Observasi lapangan & Analisa data	1 bulan sekali	Terlaksananya audit medis di setiap pelayanan prioritas standar pelayanan kedokteran	
10.	Sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien di rumah sakit (SP2KP-RS)	Sebagai bentuk partisipasi dan kepedulian petugas dalam	Setiap unit di RS	Laporan IKP	1. Terlaksana setiap kali terjadi insiden 2. Terlaksana setiap kali terjadi insiden	setiap IKP dilaporkan < 2 x 24 jam terutama KPC yang terjadi di unit	

No	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	meliputi kejadian sentinel, Kejadian yang Tidak Diharapkan (KTD), Kejadian Tidak Cedera (KTC), Kejadian Nyaris Cedera (KNC) dan Kejadian Potensial Cedera (KPC). Mekanisme pelaporan insiden keselamatan pasien baik internal maupun eksternal, grading matriks risiko serta investigasi dan analisa insiden berdasarkan hasil grading. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut: 1. Terlaksananya pelaporan IKP secara internal ke tim KPRS 2. Terlaksananya investigasi dan perbaikan berdasarkan risk matrix grading 3. Terlaksana pelaporan IKP ke	meningkatkan budaya lapor IKP yang terjadi di unitnya dan sebagai bukti bahwa RS telah memprioritaskan keselamatan pasien			3. Terlaksana setiap 3 bulan sekali 4. Terlaksana setiap bulan sekali		

No	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	representative pemilik 4. Terlaksananya pelaporan IKP secara eksternal ke KNKP						
11.	Pengukuran budaya keselamatan pasien perlu dilakukan oleh RS dengan melakukan survei budaya keselamatan pasien setiap tahun. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut: 1. Terlaksananya pengukuran budaya keselamatan 2. Terlaksananya analisa dan tindak lanjut hasil budaya keselamatan	untuk mengukur tingkat budaya keselamatan pasien dan Menyusun program kerja keselamatan pasien pada tahun berikutnya	All Staf di RS Prima Husada Malang	Survey	1 kali dalam setahun	Pengukuran dapat terlaksana dan dilaporkan kepada direktur & PT 1 kali dalam setahun	
12.	Komite Mutu membuat daftar resiko tingkat rumah sakit berdasarkan daftar resiko yang dibuat tiap unit setiap tahun. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut:	untuk menghindari resiko yang dimiliki di unit agar dapat terminimalisis kejadiannya dan menganalisis alur sebelum	Setiap unit di RS	Observasi dan analisa	1 kali dalam setahun	Tercatatatnya resiko yang terjadi di setiap unit dan pengendalian resiko di unit dapat dilaksanakan sesuai dengan	

No	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	1. Melakukan identifikasi risiko ditingkat unit dan tingkat RS 2. Menyusun Risk register 3. Menyusun strategi untuk menurunkan risiko 4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap risiko di unit 5. Terlaksananya pelaporan hasil monitoring kepada direktur dan representative pemilik 6. Menyusun FMEA 7. Melakukan monitoring tindak lanjut FMEA	insidennya terjadi				hasil pada risk register	

3.3 Cara Melaksanakan Kegiatan

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
1.	Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dan Manajemen Resiko	1. Pengajuan pelatihan eksternal ke SDM	Diklat Eksternal	- Google Zoom - Datang langsung ke penyelenggaraan pelatihan	Tentatif (Menyesuaikan Jadwal dari KARS)	1. Surat Tugas 2. Sertifikat 3. Materi 4. Laporan	
2.	Pelatihan Penyusunan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan Root Cause Analysis (RCA)	Pengajuan pelatihan eksternal ke SDM	Diklat Eksternal	- Google Zoom Datang langsung ke penyelenggaraan pelatihan	Tentatif (Menyesuaikan Jadwal dari KARS)	1. Surat Tugas 2. Sertifikat 3. Materi 4. Laporan	
3.	Pelatihan Implementasi Kendali Mutu Biaya pada bab PMKP	Pengajuan pelatihan eksternal ke SDM	Diklat Eksternal	- Google Zoom Datang langsung ke penyelenggaraan pelatihan	Tentatif (Menyesuaikan Jadwal dari KARS)	1. Surat Tugas 2. Sertifikat 3. Materi 4. Laporan	
4.	Orientasi Umum - Pengenalan Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) di RS Prima Husada Malang	1. Undangan 2. Pelaksanaan 3. LPJ	Diklat Internal	- PPT - Google Classroom	Tentatif (Menyesuaikan Jadwal dari Perekrutan SDM)	1. UMANDOK 2. Hasil Pre & Post Test 3. LPJ	
5.	<i>Refreshment & Training</i> PMKP Materi: 1. Indikator Mutu Nasional, Indikator Mutu Prioritas RS, Indikator Mutu Unit 2. Macam-macam Insiden Keselamatan Pasien dan	1. Pengajuan TOR 2. Pelaksanaan 3. LPJ	Diklat Internal	- PPT Google Classroom	Bulan Maret 2026 Bulan Maret 2026 Bulan Desember 2026 Bulan Maret 2026	1. TUMANDOK 2. Hasil Pre & Post Test 3. Sertifikat 4. LPJ	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	Alur Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien 3. Budaya Keselamatan 4. Manajemen Resiko						
6.	Pelatihan Pengambilan Data Mutu Materi: 1. Refreshment Indikator Mutu yang berlaku di Unit 2. Alur Pengumpulan Data Mutu baik di SIMRS 3. Cara analisa permasalahan sesuai dengan kondisi di unit sampai dengan tindak lanjut perbaikan 4. Praktik mengumpulkan data Mutu baik di SIMRS 5. Praktik mengunduh laporan mutu di SIMRS	1. Undangan 2. Pelaksanaan 3. LPJ	Diklat Internal	- PPT - SIMRS - Google Classroom - Google Spreadsheet	Bulan Maret 2026	1. UMANDOK 2. Hasil Pre & Post Test 3. LPJ	
7.	Pelatihan terkait pengisian CP di Unit Materi: 1. Refreshment Praktik Klinis yang dilakukan Audit 2. Pengisian Form CP di Google Spreadsheet	1. Pengajuan TOR 2. Pelaksanaan 3. LPJ	Diklat Internal	- PPT - Google Spreadsheet	Bulan Maret 2026	1. TUMANDOK 2. Hasil Pre & Post Test 3. Sertifikat 4. LPJ	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
9.	Regulasi terkait Komite Mutu. Regulasi di review dan di buat sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak ada regulasi yang <i>expired</i>. Regulasi yang perlu di review yakni: 1. Penetapan SK Komite Mutu 2. Penetapan SK PIC Mutu 3. Penetapan SK Validator Mutu 4. Penetapan Pedoman Komite Mutu RS 5. Penetapan Program Kerja Komite Mutu RS 6. Penetapan tentang Sistem Pelaporan dan Pembelajaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit (SP2KP RS) 7. Penetapan tentang Program Budaya Keselamatan Rumah Sakit 8. Penetapan tentang Program Manajemen	Membandingkan peraturan baru dan pedoman / SPO / Alur yang dimiliki oleh komite mutu	Review dokumen	Pedoman	Bulan Januari 2026	Perbaikan regulasi	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	Risiko Tingkat Rumah Sakit						
10.	Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM). Indikator Nasional Mutu adalah indikator mutu nasional yang wajib dilakukan pengukuran dan digunakan sebagai informasi mutu secara nasional. Adapun Indikator Nasional Mutu (INM) adalah sebagai berikut: 1. Kepatuhan kebersihan tangan ($\geq 85\%$) 2. Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (100%) 3. Kepatuhan identifikasi pasien (100%) 4. Waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi ($>80\%$) 5. Waktu tunggu rawat jalan ($\geq 80\%$) 6. Penundaan operasi elektif ($<5\%$) 7. Kepatuhan waktu visite dokter ($\geq 80\%$)	Melakukan pemantauan secara berkesinambungan melalui pengecekan pengambilan data, kevalidan dari lembar laporan harian kepada setiap kepala ruangan	Observasi lapangan	Instrumen pangambilan data	Januari – Desember 2026	UMANDOK	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	8. Pelaporan hasil kritis laboratorium (100%) 9. Kepatuhan penggunaan formularium nasional ($\geq 80\%$) 10. Kepatuhan terhadap alur klinis (<i>Clinical Pathway</i>) ($\geq 80\%$) 11. Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh (100%) 12. Kecepatan waktu tanggap komplain ($\geq 80\%$) 13. Kepuasan pasien (76.61%) Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut: a. Terlaksananya pengumpulan dan analisa data b. Terlaksananya pelaporan indikator mutu Nasional ke Aplikasi SIMAR c. Terlaksananya rencana perbaikan & pelaksanaan perbaikan						

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	d. Terlaksananya monitoring indikator nasional mutu						
11.	Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit (IMP-RS): 1. Direkur beserta Komite Mutu RS. Prima Husada Malang melakukan persiapan berupa pertemuan atau rapat dengan seluruh kepala ruangan, sehingga ada kesamaan pengertian tentang mutu, keselamatan pasien dan manajemen risiko sehingga ditemukan kesepakatan tentang langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan. 2. Pemilihan Indikator Mutu Prioritas RS (IMP-RS) dan sesuai dengan TKRS 5 mencakup: a. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien (ISKP)	Diskusi Bersama dengan kepala ruang, PIC, komite dan direksi untuk dilakukan grading dalam menentukan layanan prioritas yang akan di selesaikan pada tahun mendatang	FGD	Diskusi & tanya jawab	Desember 2025	UMANDOK	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	b. Indikator Pelayanan Klinis Prioritas c. Indikator sesuai Tujuan Strategis Rumah Sakit (KPI) d. Indikator terkait Perbaikan Sistem e. Indikator terkait Manajemen Risiko 3. Indikator pelayanan klinis prioritas ditetapkan melalui SK penetapan direktur. 4. Terlaksananya pengumpulan data, analisa, interpretasi data dan <i>feedback</i> data 5. Terlaksananya pelaporan capaian indikator mutu prioritas RS						
12.	Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Unit Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP – Unit) adalah indikator prioritas yang khusus dipilih kepala unit terdiri dari minimal 1 indikator. Adapun uraiannya sebagai berikut:	Diskusi Bersama dengan kepala ruang, PIC, komite dan direksi untuk menjelaskan maslaah yang terjadi di setiap unit, SPM dan memilih masalah	FGD	Instrumen pangambilan data	Desember 2025	UMANDOK	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	1. Terlaksananya pemilihan Indikator Mutu Unit 2. Terlaksananya penetapan Indikator Mutu Unit a. IGD b. Instalasi Rawat Jalan c. Instalasi Rawat Inap 2A d. Instalasi Rawat Inap 2C e. Instalasi Rawat Inap 3A f. Instalasi Rawat Inap 4A g. Instalasi Rawat Inap 3C Anak h. Instalasi Rawat Inap 5C i. Instalasi Rawat Inap 6A j. Instalasi Rawat Inap 7A k. Instalasi Rawat Inap 8A l. Instalasi Kamar Operasi m. Maternitas	yang akan di gunakan sebagai indikator mutu unit pada tahun mendatang					

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	n. Ponsek o. Neonatologi p. ICU q. HCU r. Radiologi s. Laboratorium t. Rehab Medis u. Farmasi v. Gizi w. Rekam Medis dan Pendaftaran x. K3RS y. SDM z. Kesekretariatan aa. Driver bb. Kamar Jenazah cc. IPSRS dd. Laundry ee. CSSD ff. Cleaning Service gg. Security hh. Gudang Umum ii. PPI jj. PKRS kk. Asuransi Center ll. Humas & Marketing mm. MOD-MPP-PIPP nn. TB						

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	oo. Kasir pp. HIV qq. KB rr. Stunting ss. IT-SIMRS 3. Terlaksananya pengumpulan dan analisa data						
13.	Analisa, Pelaporan dan <i>feedback</i> data indikator mutu terintegrasi 1. Terlaksananya pengumpulan data indikator mutu oleh PIC di setiap unit kerja sesuai dengan profil indikator 2. Terlaksananya analisa data pencapaian indikator sesuai dengan ketentuan analisa data 3. Terlaksananya validasi data sesuai dengan ketentuan validasi data 4. Terlaksananya pelaporan data indikator mutu dari tingkat unit sampai dengan ke pemilik 5. Terlaksananya penyampaian <i>feedback</i>	Melakukan pemantauan secara berkesinambungan melalui pengecekan pengambilan data, kevalidan dari lembar laporan harian kepada setiap kepala ruangan	Observasi lapangan & Analisa data	Instrumen pengambilan data	Januari – desember 2026	UMANDOK	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	hasil capaian indikator mutu ke semua staf di unit kerja 6. Terlaksananya publikasi data indikator mutu 7. Terlaksananya <i>benchmark</i> data						
14.	Penerapan Standar Pelayanan Kedokteran di Rumah Sakit. Terkait dengan pengukuran prioritas perbaikan pelayanan klinis yang ditetapkan oleh Direktur, maka direktur bersama-sama dengan pimpinan medis, ketua komite medik menetapkan paling sedikit 5 evaluasi pelayanan prioritas standar pelayanan kedokteran. 1. Terlaksananya evaluasi CP dengan Komite Medik 2. Terlaksananya audit medis dengan Pimpinan Medis dan Komite Medik	Melakukan pemantauan CP Pasien dengan membandingkan observasi lapangan	Observasi lapangan & Analisa data	Instrumen pangambilan data	Januari – desember 2026	UMANDOK	
15.	Sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien di rumah sakit	Melaporkan insiden yang terjadi di unit	Laporan langsung / tidak langsung	Instrumen pangambilan data	Januari – desember 2026	UMANDOK	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	(SP2KP-RS) meliputi kejadian sentinel, Kejadian yang Tidak Diharapkan (KTD), Kejadian Tidak Cedera (KTC), Kejadian Nyaris Cedera (KNC) dan Kejadian Potensial Cedera (KPC). Mekanisme pelaporan insiden keselamatan pasien baik internal maupun eksternal, grading matriks risiko serta investigasi dan analisa insiden berdasarkan hasil grading. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut: 1. Terlaksananya pelaporan IKP secara internal ke tim KPRS 2. Terlaksananya investigasi dan perbaikan berdasarkan risk matrix grading 3. Terlaksana pelaporan IKP ke representative pemilik 4. Terlaksananya pelaporan IKP secara eksternal ke KNKP	menggunakan form laporan dan billing RS					
16.	Pengukuran budaya keselamatan pasien perlu	Melakukan survei secara online	Survey	Instrumen pangambilan data	Juni 2026	UMANDOK	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	dilakukan oleh RS dengan melakukan survei budaya keselamatan pasien setiap tahun. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut: 1. Terlaksananya pengukuran budaya keselamatan 2. Terlaksananya analisa dan tindak lanjut hasil budaya keselamatan	menggunakan google form dengan sasaran seluruh petugas					
17.	Komite Mutu membuat daftar resiko tingkat rumah sakit berdasarkan daftar risiko yang dibuat tiap unit setiap tahun. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut: 1. Melakukan identifikasi risiko ditingkat unit dan tingkat RS 2. Menyusun Risk register 3. Menyusun strategi untuk menurunkan risiko 4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap risiko di unit 5. Terlaksananya pelaporan hasil monitoring kepada	Melakukan Analisa resiko yang mungkin terjadi di unitnya Bersama dengan kepala ruang dan tim manajemen risiko dan membuat risk register	Observasi dan analisa	Instrumen pangambilan data	Desember 2025	UMANDOK	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	direktur dan representative pemilik 6. Menyusun FMEA 7. Melakukan monitoring tindak lanjut FMEA						

3.4 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2026

NO	KEGIATAN	SASARAN	TAHUN 2026												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET
			12/ 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dan Manajemen Risiko	1. Ketua PMKP 2. Sekretaris PMKP 3. Ketua Sub Komite Peningkatan Mutu 4. Ketua Sub Keselamatan Pasien 5. Ketua Sub Manajemen Risiko	Menyesuiakan Jadwal Pelatihan PMKP dan Manajemen Risiko dari KARS												Tergantung Penyelenggaraan	SDM RS	PT Disa Prima Medika	
3.	Pelatihan Penyusunan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan Root Cause Analysis (RCA)	1. Ketua PMKP 2. Sekretaris PMKP 3. Ketua Sub Keselamatan Pasien	enyesuikan Jadwal Pelatihan PMKP dan Manajemen Risiko dari KARS												Tergantung Penyelenggaraan	SDM RS	PT Disa Prima Medika	
4.	Pelatihan Implementasi Kendali Mutu Biaya pada bab PMKP	1. Ketua PMKP 2. Sekretaris PMKP 3. Ketua Sub Komite					√								Zoom	SDM RS	PT Disa Prima Medika	

NO	KEGIATAN	SASARAN	TAHUN 2026												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET
			12/ 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Peningkatan Mutu																
5.	Orientasi Umum - Pengenalan Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) di RS Prima Husada Malang	Karyawan Baru	Menyesuaikan Jadwal Orientasi dari SDM RS Prima Husada Malang												Hall Sakura Rumah Sakit Prima Husada Malang	Komite PMKP	-	
6.	<i>Refreshment & Training</i> PMKP Materi: 1. Indikator Mutu Nasional, Indikator Mutu Prioritas RS, Indikator Mutu Unit 2. Macam-macam Insiden Keselamatan Pasien dan Alur Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien 3. Budaya Keselamatan 4. Manajemen Resiko	Seluruh Staff di RS Prima Husada Malang				√									√	Hall Sakura Rumah Sakit Prima Husada Malang	Komite PMKP	-
7.	Pelatihan Pengambilan Data Mutu Materi: 1. Refreshment Indikator Mutu yang berlaku di Unit	PIC Data Mutu Unit				√										Hall Sakura Rumah Sakit Prima Husada Malang	Komite PMKP	-

NO	KEGIATAN	SASARAN	TAHUN 2026												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET	
			12/ 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
	2. Alur Pengumpulan Data Mutu baik di SIMRS maupun <i>Google Spreadsheet</i> 3. Cara analisa permasalahan sesuai dengan kondisi di unit sampai dengan tindak lanjut perbaikan 4. Praktik mengumpulkan data Mutu baik di SIMRS maupun <i>Google Spreadsheet by name</i> . 5. Praktik mengunduh laporan mutu di SIMRS																		
8.	Pelatihan terkait pengisian CP di Unit Materi: 1. Refreshment Praktik Klinis yang dilakukan Audit 2. Pengisian Form CP di Google Spreadsheet	Karu Rawat Inap, Dokter, Gizi, Farmasi														Hall Rumah Prima Malang Sakura Sakit Husada	Komite PMKP Komite Medik	-	
9.	Regulasi terkait Komite Mutu. Regulasi yang perlu di review yakni:			√															
	a. Penetapan SK Komite Mutu	Direktur RS		√												Sekretariat	Komite PMKP	-	-
	b. Penetapan SK PIC Mutu	Komite PMKP		√															

NO	KEGIATAN	SASARAN	TAHUN 2026													TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET
			12/ 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	c. Penetapan SK Validator Mutu	Direktur RS		√															
	d. Penetapan Pedoman Komite Mutu RS	Direktur RS		√															
	e. Penetapan Program Kerja Komite Mutu RS	Direktur RS		√															
	f. Penetapan tentang Sistem Pelaporan dan Pembelajaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit (SP2KP RS)	Direktur RS		√															
	g. Penetapan tentang Program Budaya Keselamatan Rumah Sakit	Direktur RS		√															
	l. Penetapan tentang Program Manajemen Risiko Tingkat Rumah Sakit	Direktur RS		√															
10.	Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM). Indikator Nasional Mutu adalah indikator mutu nasional yang wajib dilakukan pengukuran dan digunakan sebagai informasi mutu secara nasional.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				

NO	KEGIATAN	SASARAN	TAHUN 2026													TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET
			12/ 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	a. Terlaksananya pengumpulan dan analisa data	All Unit	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	b. Terlaksananya pelaporan indikator mutu Nasional ke Aplikasi SIMAR	Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	c. Terlaksananya rencana perbaikan & pelaksanaan perbaikan	Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	d. Terlaksananya monitoring indikator nasional mutu	Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
11.	Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit (IMP-RS):			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
	Direkur beserta Komite Mutu RS. Prima Husada Malang melakukan persiapan berupa pertemuan atau rapat dengan seluruh kepala ruangan, sehingga ada kesamaan pengertian tentang mutu, keselamatan pasien dan manajemen risiko sehingga ditemukan kesepakatan tentang langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan.	Direktur RS & Komite PMKP	√													Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-

NO	KEGIATAN	SASARAN	TAHUN 2026												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET	
			12/ 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
	Pemilihan Indikator Mutu Prioritas RS (IMP-RS) dan sesuai dengan TKRS 5 mencakup: a. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien (ISKP) b. Indikator Pelayanan Klinis Prioritas c. Indikator sesuai Tujuan Strategis Rumah Sakit (KPI) d. Indikator terkait Perbaikan Sistem e. Indikator terkait Manajemen Risiko	Direktur RS & Komite PMKP	√													Hall Andalusia Lantai 3	Komite PMKP	-	-
	Indikator pelayanan klinis prioritas ditetapkan melalui SK penetapan direktur	Direktur RS	√													Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	Terlaksananya pengumpulan data, analisa, interpretasi data dan <i>feedback</i> data	Komite PMKP		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	Terlaksananya pelaporan capaian indikator mutu prioritas RS	Komite PMKP		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
12.	Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Unit		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				

NO	KEGIATAN	SASARAN	TAHUN 2026												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET		
			12/ 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	
	Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP – Unit) adalah indikator prioritas yang khusus dipilih kepala unit terdiri dari minimal 1 indikator.																			
	Terlaksananya pemilihan Indikator Mutu Unit	Komite PMKP Kepala Unit	√													Hall Rumah Prima Malang	Sakura Sakit Husada	Komite PMKP	-	-
	Terlaksananya penetapan Indikator Mutu Unit a. IGD b. Instalasi Rawat Jalan c. Instalasi Rawat Inap 2A d. Instalasi Rawat Inap 2C e. Instalasi Rawat Inap 3A f. Instalasi Rawat Inap 4A g. Instalasi Rawat Inap 3C Anak h. Instalasi Rawat Inap 5C i. Instalasi Rawat Inap 6A j. Instalasi Rawat Inap 7A		√													Hall Rumah Prima Malang	Sakura Sakit Husada	Komite PMKP	-	-

[illegible]

NO	KEGIATAN	SASARAN	TAHUN 2026												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET	
			12/ 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
	kk. Asuransi Center ll. Humas & Marketing mm. MOD-MPP-PIPP nn. TB oo. Kasir pp. HIV qq. KB rr. Stunting IT-SIMRS																		
	Terlaksananya pengumpulan dan analisa data	Komite PMKP Kepala Unit		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
13	Analisa, Pelaporan dan <i>feedback</i> data indikator mutu terintergrasi		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
	a. Terlaksananya pengumpulan data indikatotor mutu oleh PIC disetiap unit kerja sesuai dengan profil indikator	Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	b. Terlaksananya analisa data pencapaian indikator sesuai dengan ketentuan analisa data	Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-

NO	KEGIATAN	SASARAN	TAHUN 2026													TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET
			12/ 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	c. Terlaksananya validasi data sesuai dengan ketentuan	Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	d. Terlaksananya pelaporan data indikator mutu dari tingkat unit sampai dengan ke pemilik	PIC Data Mutu Kepala Unit Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	e. Terlaksananya penyampaian <i>feedback</i> hasil capaian indikator mutu ke semua staf di unit kerja	Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	f. Terlaksananya publikasi data indikator mutu	Komite PMKP		√			√			√			√			Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	g. Terlaksananya <i>benchmark</i> data	Komite PMKP		√			√			√			√			Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
14.	Penerapan Standar Pelayanan Kedokteran di Rumah Sakit.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
	a. Terlaksananya evaluasi CP dengan Komite Medik	Komite Medik Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	b. Terlaksananya audit medis dengan Pimpinan Medis dan Komite Medik	Komite Medik Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
15.	Sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien di rumah sakit		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				

[illegible]

NO	KEGIATAN	SASARAN	TAHUN 2026												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET	
			12/ 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
	melakukan survei budaya keselamatan pasien setiap tahun.																		
	a. Terlaksananya pengukuran budaya keselamatan	All Karyawan RSPH Malang							√							Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	b. Terlaksananya analisa dan tindak lanjut hasil budaya keselamatan	Komite PMKP							√	√						Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
17.	Komite Mutu membuat daftar resiko tingkat rumah sakit berdasarkan daftar risiko yang dibuat tiap unit setiap tahun.		√																
	a. Melakukan identifikasi risiko ditingkat unit dan tingkat RS	All Unit	√													Hall Sakura Rumah Sakit Prima Husada Malang	Komite PMKP Komite PPI Komite K3RS	-	-
	b. Menyusun Risk register	Komite PMKP	√													Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	c. Menyusun strategi untuk menurunkan risiko	Komite PMKP	√													Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	d. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap risiko di unit	Komite PMKP	√													Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	e. Terlaksananya pelaporan hasil monitoring kepada	Komite PMKP	√													Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-

NO	KEGIATAN	SASARAN	TAHUN 2026													TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET
			12/ 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	direktur dan representative pemilik																		
	f. Menyusun FMEA	Komite PMKP	√													Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	g. Melakukan monitoring tindak lanjut FMEA	Komite PMKP	√													Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-

3.5 Kebutuhan Anggaran

Semua anggaran akan dibiayai dari anggaran Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah disetujui oleh PT. Disa Prima Medika dengan rincian sebagaimana terlampir :

Tabel 3.5. Kebutuhan biaya pengembangan SDM Komite PMKP tahun 2026

No	Kegiatan/Rincian Kegiatan	Internal Eksternal	Jumlah (Satuan)	Harga Satuan	Total
1	Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dan Manajemen Resiko	Eksternal	2	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000
2	Pelatihan Penyusunan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan Root Cause Analysis (RCA)	Eksternal	2	Rp 3.500.000	Rp 7.000.000
3	Pelatihan Implementasi Kendali Mutu Biaya pada bab PMKP	Eksternal	1	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
4	Orientasi Umum - Pengenalan Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) di RS Prima Husada Malang	Internal	3	Rp 20.000	Rp 60.000
5	<i>Refreshment & Training</i> PMKP Materi: a. Indikator Mutu Nasional, Indikator Mutu Prioritas RS, Indikator Mutu Unit b. Macam-macam Insiden Keselamatan Pasien dan Alur Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien c. Budaya Keselamatan d. Manajemen Resiko	Internal	3	Rp 20.000	Rp 60.000
7	Pelatihan Pengambilan Data Mutu	Internal	2	Rp 20.000	Rp 40.000

No	Kegiatan/Rincian Kegiatan	Internal Eksternal	Jumlah (Satuan)	Harga Satuan	Total
	Materi: a. Refreshment Indikator Mutu yang berlaku di Unit b. Alur Pengumpulan Data Mutu baik di SIMRS c. Cara analisa permasalahan sesuai dengan kondisi di unit sampai dengan tindak lanjut perbaikan d. Praktik mengumpulkan data Mutu baik di SIMRS e. Praktik mengunduh laporan mutu di SIMRS				
8	Pelatihan terkait pengisian CP di Unit Materi: a. Refreshment Praktik Klinis yang dilakukan Audit b. Pengisian Form CP di Google Spreadsheet	Internal	2	Rp 20.000	Rp 40.000
9	Honorarium narasumber pelatihan insidentil (DPJP) 4 kali pelatihan x 4 org DPJP	Eksternal	20	Rp 250.000	Rp 5.000.000
TOTAL					Rp 24.200.000

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

4.1. Monitoring

Sesuai dengan Permenkes No. 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit, kegiatan monitoring Komite PMKP dilakukan dalam bentuk:

1. Monitoring, supervisi dan memandu penerapan program mutu di unit kerja
2. Monitoring, supervisi dan memandu unit kerja dalam memilih prioritas perbaikan, pengukuran mutu/indikator mutu, dan menindaklanjuti hasil capaian indikator mutu
3. Monitoring, supervisi dan memandu penerapan keselamatan pasien di unit kerja
4. Monitoring, supervisi dan memandu penerapan manajemen risiko di unit kerja

4.2. Evaluasi

Sesuai dengan Permenkes No. 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit, kegiatan evaluasi Komite PMKP dilakukan dalam bentuk:

1. Rapat rutin dengan PIC Data Unit terkait capaian indikator mutu unit setiap bulan
2. Rapat Triwulanan dengan Kepala Ruang dan Jajaran Manajemen terkait capaian indikator mutu, insiden keselamatan pasien yang ada di unit
3. Pemberian masukan dan pertimbangan kepada Direktur Rumah Sakit terkait perbaikan mutu tingkat Rumah Sakit
4. Rapat pemilihan prioritas perbaikan tingkat Rumah Sakit dan pengukuran indikator tingkat Rumah Sakit serta menindaklanjuti hasil capaian indikator
5. Rapat pemilihan risk register unit dengan Kepala Ruang, Seluruh Komite dan jajaran Manajemen untuk dilakukan profil register.
6. Motivasi, edukasi, konsultasi, pemantauan dan penilaian tentang penerapan program keselamatan pasien
7. Melakukan Root Cause Analysis (RCA) dan pemberian solusi untuk meningkatkan keselamatan pasien
8. Evaluasi dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali oleh bidang bagian dan dianalisa setiap triwulan, untuk di berikan rekomendasi dan di sampaikan kepada Pemilik (Direktur PT)
9. Setelah ada feedback maka disampaikan melalui direktur ke Komite Mutu, Komite Mutu menyampaikan feedback kepada manajer untuk ditindak lanjuti

BAB V

PENCATATAN DAN PELAPORAN

1. Kegiatan pengumpulan data indikator mutu di lakukan oleh PIC data unit dengan menggunakan SIMRS
2. Data yang dikumpulkan diverifikasi oleh kepala instalasi dan dilihat apakah sudah sesuai dengan profil indikator atau belum.
3. Setiap capaian indikator di rekapitulasi setiap bulan, dilengkapi dengan analisa dan tindak lanjut.
4. Setiap tiga bulan, data tersebut direkap dan dianalisis oleh manajer menjadi laporan triwulan sebagai bentuk evaluasi unit.
5. Komite Mutu bertugas melakukan validasi data hasil kegiatan jika hasil kegiatan jika ada data yang harus dievaluasi sesuai kebutuhan dalam prosedur validasi.
6. Setelah data valid maka laporan dari hasil analisa analisa setiap unit direkap menjadi laporan hasil kegiatan rumah sakit, Direktur RS melaporkan kepada Direktur PT Pemilik RS
7. Setelah ada Feedback dari Direktur PT Pemilik RS kepada Direktur RS maka disosialisasikan kepada semua manajer untuk penyusunan tindak lanjut dan diinformasikan kepada semua staf diunit kerja.
8. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh dari setiap kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan, hasil evaluasi disampaikan oleh Komite Mutu dan diserahkan ke Direktur PT Pemilik RS untuk ditindaklanjuti.

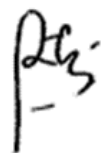
BAB VI
PENUTUP

Demikian program PMKP disusun dan disampaikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di RS Prima Husada Malang tahun 2026. Segala dukungan dan kerjasama yang diberikan dapat menunjang terlaksananya program yang sudah disusun.

Malang, 17 Desember 2025

Mengetahui

Ketua Komite Mutu



dr. Ari Putriani, Sp.PK

Menyetujui,

PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestianti, M.Kes